

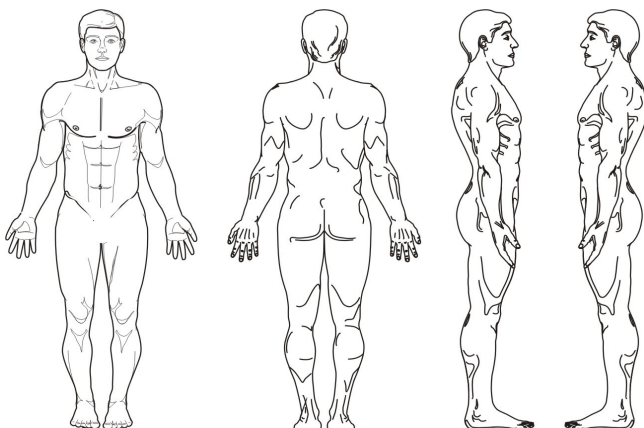
 Intensivpflege-Halle-GmbH	Pflege von Menschen mit chronischen Wunden	QM- Handbuch
	Expertenstandard 03	Anlage

Übersicht: Merkmale eines venösen bzw. arteriellen Ulcus cruris		
	Arteriell Ulcus cruris	Venöses Ulcus cruris
Entstehung Ursachen Risiken	Die arteriellen Beingeschwüre entstehen, wenn die Durchblutung eines Körperteils z. B. aufgrund einer Arterienverkalkung erheblich geschwächt worden ist. Risiken hierfür sind: ☐ Rauchen ☐ erhöhter Blutdruck ☐ Diabetes ☐ Gicht ☐ Herz- /Kreislauferkrankungen ☐ Arterienverkalkung der Beine	Die Hauptursache für das Geschwür ist, dass die Klappen des Venensystems, das die oberflächlichen und die tiefen Venen der Beine verbindet, nicht funktionieren. Risiken hierfür sind: ☐ eingeschränktes Venensystem ☐ Beinbrüche oder andere Beinschädigungen ☐ Thrombose in einer tiefen Beinvene ☐ Vorangegangene OP am betroffenen Bein ☐ sitzende o. stehende Tätigkeit ☐ Venenentzündung (Phlebitis) ☐ Übergewicht
Lokalisation	Die Geschwüre kommen meist an den Füßen, Zehen und Fersen vor. Füße und Beine fühlen sich kalt an und sehen evtl. bläulich aus.	Die venösen Beingeschwüre kommen meist im Bereich der Knöchel vor, besonders an der Innenseite des Beins.
Symptome	Die arteriellen Beingeschwüre sind in der Regel schmerzhaft. Die Schmerzen sind am schlimmsten, wenn man ruht, und können besonders in der Nacht sehr stark sein. Den Schmerzen ist abzuweichen, indem man die Unterschenkel u. Füße aus dem Bett hängen lässt, sodass mehr Blut in die Beine fließt u. sie besser durchblutet werden.	Ein Bein mit venösen Problemen ist an seinem charakteristischen Aussehen zu erkennen. Das Bein ist geschwollen. Besonders um bereits bestehende Geschwüre ist die Haut stellenweise bräunlich verfärbt, die Haut ist trocken und juckt (Stasissekzem). Das Geschwür selbst ist oft feucht und nässend, in der Regel aber schmerzlos.
Behandlungsmöglichkeiten laut ärztlicher Anordnung	☐ medikamentöse Therapie ☐ moderne Wundversorgung ☐ Gefäßerweiterung durch operativen Eingriff ☐ Tieflagerung der Beine	☐ Kompressionsverband ☐ moderne Wundversorgung ☐ kontinuierliche Hautpflege ☐ Hochlagerung der Beine ☐ medikamentöse Therapie ☐ evtl. Venenentfernung
Risiko-minimierung	☐ Rauchen einstellen ☐ fettarme Ernährung ☐ viel Obst und Gemüse ☐ Bewegung, auch im Sitzen, z.B. Kreisbewegungen mit den Füßen u. Auf-/Abbewegungen der Fersen ☐ Gewichtsreduzierung bei Übergewicht ☐ passendes Schuhwerk ☐ regelmäßige Untersuchung der Füße und Unterschenkel auf Farbveränderungen und Wunden; dies gilt besonders bei an Diabetes Erkrankten. ☐ Füße warm halten ☐ Verletzungen an Füßen und Unterschenkel vermeiden ☐ regelmäßige Fußpflege	☐ mehr Bewegung ☐ fettarme Ernährung ☐ viel Obst und Gemüse ☐ Gewichtsreduzierung bei Übergewicht ☐ Beine hochlagern ☐ passendes Schuhwerk ☐ regelmäßige Untersuchung der Füße und Unterschenkel auf Farbveränderungen und Wunden; dies gilt besonders bei an Diabetes Erkrankten. ☐ regelmäßige Fußpflege durch Fachpersonal ☐ Übereinanderschlagen der Beine vermeiden ☐ regelmäßige Änderung der Arbeitshaltung
Quelle: pdl.konkret ambulant , Verlag PRO PflegeManagement , www.pflege-management.de , 2010		

	erstellt	überarbeitet	geprüft / bearbeitet			freigegeben		
Datum	12/2020	01/2026						
Unterschrift								

 Intensivpflege-Halle-GmbH	Pflege von Menschen mit chronischen Wunden	QM- Handbuch
	Expertenstandard 03	Anlage

Wundassessment – Dekubitus

Patient/ in	Geburtsdatum
1. Medizinische Wunddiagnose	
Grunderkrankungen	
Einteilung der Wunde nach EPUAP bzw. der Grunderkrankung ☐ Dekubitus Kategorie 1 (nicht wegdrückbare Rötung intakter Haut; besonders bei dunkelhäutigen Menschen können auch Hautverfärbungen, Überwärmung, Ödeme oder Verhärtungen Indikatoren für Kategorie 1 sein) ☐ Dekubitus Kategorie 2 (Teilverlust der Haut, mit Schädigung von Epidermis, Dermis oder beiden Hautschichten; Dekubitus ist oberflächlich und manifestiert sich klinisch als Hautabschürfung oder Blase) ☐ Dekubitus Kategorie 3 (Verlust aller Hautschichten einschließlich Schädigung oder Nekrose des subkutanen Gewebes, die bis auf, aber nicht unter die darunterliegende Faszie reichen kann) ☐ Dekubitus Kategorie 4 (ausgedehnte Zerstörung, Gewebse Nekrose oder Schädigung von Muskeln, Knochen oder stützenden Strukturen, mit oder ohne Verlust aller Hautschichten) ☐ vollständiger Haut oder Gewebeverlust – unbekannte Tiefe (tatsächliche Tiefe der Wunde von Belag und Wundkruste/Schorf im Wundbett verdeckt) ☐ vermutete tiefe Gewebsschädigung – unbekannte Tiefe (violetter oder rötlichbrauner, umschriebener Bereich verfärbter, intakter Haut oder blutgefüllte Blase aufgrund einer Schädigung des darunterliegenden Weichgewebes durch Druck und/oder Scherkräfte)	
bisherige diagnostische und therapeutische Maßnahmen	
2. Wundlokalisation	
graphische Dokumentation anhand eines Körperschemas 	
fachlich korrekte verbale Dokumentation ☐ cranial ☐ dorsal ☐ caudal ☐ plantar ☐ proximal ☐ distal ☐ anterior ☐ posterior ☐ superior ☐ inferior ☐ lateral ☐ medial ☐ ventral ☐.....	
3. Wunddauer	
Wunde besteht seit	Entstehungsort:
4. Rezidivzahl	
Zahl der Rezidive:	Rezidivfreie Zeit:
Beschreibung	

 Intensivpflege-Halle-GmbH	Pflege von Menschen mit chronischen Wunden	QM- Handbuch
	Expertenstandard 03	Anlage

5. Wundgröße									
Länge (in cm)									
Breite (in cm)									
Tiefe (in cm)									
6. Unterminierung									
☐ ja >									
☐ nein									
7. Wundgrund/ Gewebeart									
☐ Granulationsgewebe									
☐ Fibringewebe									
☐ Epithelgewebe									
☐ Nekrose									
☐ Muskeln									
☐ Faszie									
☐ Sehnen									
☐ Knochen									
☐ Fettgewebe									
☐ Dermis									
☐ Sonstiges									
8. Exsudat/ Transsudat									
Häufigkeit des Verbandwechsels									
Anzahl der durchnässten Kompressen									
☐ kein: abgeheilt oder trockene Wunde									
☐ wenig: Wundbett feucht, Verband trocken									
☐ gering: Wundbett feucht, etwas aus dem Verband austretend									
☐ moderat: deutlich flüssig im Wundbett, über 50% d. Verbandes erschöpft									
☐ serös / blutig (serosanguinous): wässrig, hell rot bis rosa									
☐ serös: wässrig, klar, hell, gelblich									
☐ serös / eitrig: undurchsichtig									
☐ eitrig: undurchsichtig, gelblich bis grün mit faulem / schlechten Geruch									
☐ Sonstiges									
9. Wundgeruch									
☐ ja									
☐ nein									
10. Wundrand									
☐ intakt									
☐ nekrotisch									
☐ unterminiert									
☐ wulstig									
☐ mazeriert									
☐ rosig									
☐ Sonstiges									
Rückschluss auf Wundheilungsstörung									
☐ Bildung von Hyperkeratosen									
☐ Nekrosen und Einblutungen durch unzureichende Druckentlastung									
☐ Sonstiges									
11. Wundumgebung									
☐ intakt									
☐ gerötet									
☐ geschwollen									
☐ mazeriert									
☐ trocken									
☐ feucht									
☐ Wärmeentwicklung									
☐ die Farbe									
☐ Rückschluss auf Infektionen									
☐ Rückschluss auf mangelnde Druckentlastung									
☐ Rückschluss auf Hautirritationen durch Kompressionsstrümpfe									
☐ Sonstiges									

 Intensivpflege-Halle-GmbH	Pflege von Menschen mit chronischen Wunden	QM- Handbuch Kapitel ...
	Expertenstandard 03	Anlage 4

Wundassessment – Ulcus Cruris venosum

Patient/ in	Geburtsdatum
-------------	--------------

1. Medizinische Wunddiagnose

Grunderkrankungen

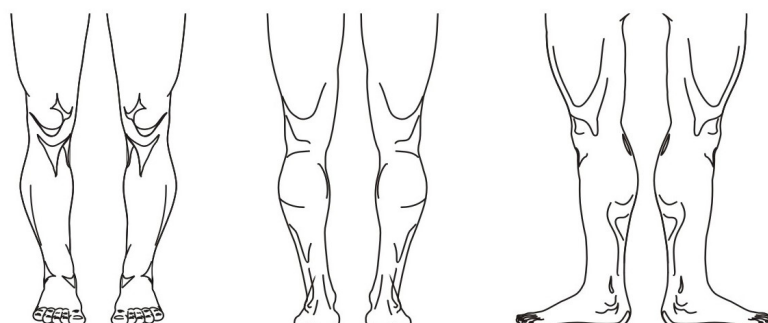
Schweregradeinteilung der Wunde bzw. der Grunderkrankung (der Expertenstandard empfiehlt die Klassifizierung von Widmer)

- ☐ **Stadium 1** (reversible Ödeme; Corona phlebectatica (dunkel-blaue Hautveränderungen am medialen und lateralen Fussrand); perimalleoläre Kőlbchenvenen)
- ☐ **Stadium 2** (persistierende Ödeme; Hämosiderose und Purpura der Haut im Unterschenkelbereich; Dermatosklerosen und Lipodermatosklerose; Atrophie blanche; Stauungsekzem; zyanotische Hautfarbe)
- ☐ **Stadium 3** (Ulcer cruris; Unterschenkelgeschwür oder Ulkusnarbe)

bisherige diagnostische und therapeutische Maßnahmen

2. Wundlokalisation

graphische Dokumentation anhand eines Körperschemas



fachlich korrekte verbale Dokumentation

- ☐ cranial ☐ dorsal ☐ caudal ☐ plantar ☐ proximal ☐ distal ☐ anterior
☐ posterior ☐ superior ☐ inferior ☐ lateral ☐ medial ☐ ventral
- ☐.....

3. Wunddauer

Wunde besteht seit Entstehungsort:

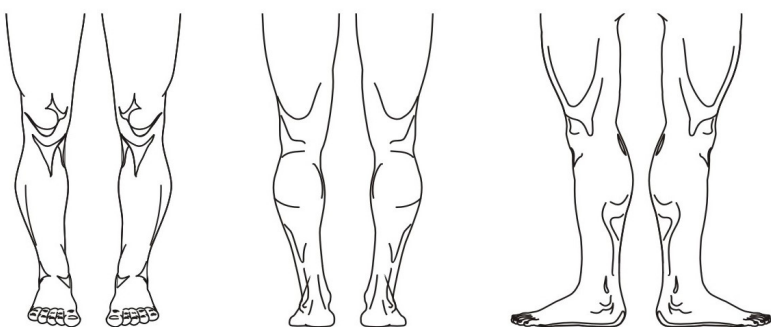
4. Rezidivzahl

Zahl der Rezidive:	Rezidivfreie Zeit:
Beschreibung	
.....	
.....	
.....	

 Intensivpflege-Halle-GmbH	Pflege von Menschen mit chronischen Wunden	QM- Handbuch Kapitel ...
	Expertenstandard 03	Anlage 4

5. Wundgröße									
Länge (in cm)									
Breite (in cm)									
Tiefe (in cm)									
6. Unterminierung									
☐ ja >									
☐ nein									
7. Wundgrund/ Gewebeart									
☐ Granulationsgewebe									
☐ Fibringewebe									
☐ Epithelgewebe									
☐ Nekrose									
☐ Muskeln									
☐ Faszie									
☐ Sehnen									
☐ Knochen									
☐ Fettgewebe									
☐ Dermis									
☐ Sonstiges									
8. Exsudat/ Transsudat									
Häufigkeit des Verbandwechsels									
Anzahl der durchnässten Kompressen									
☐ kein: abgeheilt oder trockene Wunde									
☐ wenig: Wundbett feucht, Verband trocken									
☐ gering: Wundbett feucht, etwas aus dem Verband austretend									
☐ moderat: deutlich flüssig im Wundbett, über 50% d. Verbandes erschöpft									
☐ serös / blutig (serosanguinous): wässrig, hell rot bis rosa									
☐ serös: wässrig, klar, hell, gelblich									
☐ serös / eitrig: undurchsichtig									
☐ eitrig: undurchsichtig, gelblich bis grün mit faulem / schlechten Geruch									
☐ Sonstiges									
9. Wundgeruch									
☐ ja									
☐ nein									
10. Wundrand									
☐ intakt									
☐ nekrotisch									
☐ unterminiert									
☐ wulstig									
☐ mazeriert									
☐ rosig									
☐ Sonstiges									
Rückschluss auf Wundheilungsstörung									
☐ Bildung von Hyperkeratosen									
☐ Nekrosen und Einblutungen durch unzureichende Druckentlastung									
☐ Sonstiges									
11. Wundumgebung									
☐ intakt									
☐ gerötet									
☐ geschwollen									
☐ mazeriert									
☐ trocken									
☐ feucht									
☐ Wärmeentwicklung									
☐ die Farbe									
☐ Rückschluss auf Infektionen									
☐ Rückschluss auf mangelnde Druckentlastung									
☐ Rückschluss auf Hautirritationen durch Kompressionsstrümpfe									
☐ Sonstiges									

 Intensivpflege-Halle-GmbH	Pflege von Menschen mit chronischen Wunden	QM- Handbuch Kapitel ...
	Expertenstandard 03	Anlage 5

Wundassessment – Ulcus Cruris arteriosum	
Patient/ in	Geburtsdatum
1. Medizinische Wunddiagnose	
Grunderkrankungen 	
Schweregradeinteilung der Wunde bzw. der Grunderkrankung (der Expertenstandard empfiehlt die Klassifizierung von Fontaine) ☐ Stadium I (symptomlos, evt. leichte Ermüdbarkeit beim Gehen) ☐ Stadium IIa (ab einer Gehstrecke von 200m setzen Schmerzen ein) ☐ Stadium IIb (Schmerzen bei einer Gehstrecke unter 200m) ☐ Stadium III (Ruheschmerz) ☐ Stadium IV (Dauerschmerz, Ulcus, Nekrose, Gangrän)	
bisherige diagnostische und therapeutische Maßnahmen	
2. Wundlokalisation	
graphische Dokumentation anhand eines Körperschemas 	
fachlich korrekte verbale Dokumentation ☐ cranial ☐ dorsal ☐ caudal ☐ plantar ☐ proximal ☐ distal ☐ anterior ☐ posterior ☐ superior ☐ inferior ☐ lateral ☐ medial ☐ ventral ☐	
3. Wunddauer	
Wunde besteht seit	Entstehungsort:
4. Rezidivzahl	
Zahl der Rezidive:	Rezidivfreie Zeit:
Beschreibung	

 Intensivpflege-Halle-GmbH	Pflege von Menschen mit chronischen Wunden	QM- Handbuch Kapitel ...
	Expertenstandard 03	Anlage 5

5. Wundgröße									
Länge (in cm)									
Breite (in cm)									
Tiefe (in cm)									
6. Unterminierung									
☐ ja >									
☐ nein									
7. Wundgrund/ Gewebeart									
☐ Granulationsgewebe									
☐ Fibringewebe									
☐ Epithelgewebe									
☐ Nekrose									
☐ Muskeln									
☐ Faszie									
☐ Sehnen									
☐ Knochen									
☐ Fettgewebe									
☐ Dermis									
☐ Sonstiges									
8. Exsudat/ Transsudat									
Häufigkeit des Verbandwechsels									
Anzahl der durchnässten Kompressen									
☐ kein: abgeheilt oder trockene Wunde									
☐ wenig: Wundbett feucht, Verband trocken									
☐ gering: Wundbett feucht, etwas aus dem Verband austretend									
☐ moderat: deutlich flüssig im Wundbett, über 50% d. Verbandes erschöpft									
☐ serös / blutig (serosanguinous): wässrig, hell rot bis rosa									
☐ serös: wässrig, klar, hell, gelblich									
☐ serös / eitrig: undurchsichtig									
☐ eitrig: undurchsichtig, gelblich bis grün mit faulem / schlechten Geruch									
☐ Sonstiges									
9. Wundgeruch									
☐ ja									
☐ nein									
10. Wundrand									
☐ intakt									
☐ nekrotisch									
☐ unterminiert									
☐ wulstig									
☐ mazeriert									
☐ rosig									
☐ Sonstiges									
Rückschluss auf Wundheilungsstörung									
☐ Bildung von Hyperkeratosen									
☐ Nekrosen und Einblutungen durch unzureichende Druckentlastung									
☐ Sonstiges									
11. Wundumgebung									
☐ intakt									
☐ gerötet									
☐ geschwollen									
☐ mazeriert									
☐ trocken									
☐ feucht									
☐ Wärmeentwicklung									
☐ die Farbe									
☐ Rückschluss auf Infektionen									
☐ Rückschluss auf mangelnde Druckentlastung									
☐ Rückschluss auf Hautirritationen durch Kompressionsstrümpfe									
☐ Sonstiges									
Protokoll- Version-Nr. 1									

 Intensivpflege-Halle-GmbH	Pflege von Menschen mit chronischen Wunden	QM- Handbuch Kapitel ...
	Expertenstandard 03	Anlage 10

Zusatzinstrument „Wittener Aktivitätenkatalog“ BEI VENÖS BEDINGT OFFENEN BEINEN

Patient/ in	Geb.datum	Erhebungsdatum
-------------	-----------	----------------

1 Maßnahmen zur Verhinderung eines Blutstaus in den Beinen				
1.1 Maßnahmen zur Kompression	ja, stimmt genau (1)	eher ja (2)	eher nein (3)	nein, stimmt nicht (4)
1.1.a allgemein				
1. wenn ich ein geschlossenes Bein habe, ziehe ich einen Kompressionsstrumpf an				
2. ich lege den Kompressionsverband/ -strumpf morgens sofort beim Aufstehen an				
3. wenn das Bein vor dem Anlegen der Kompression geschwollen ist, lege ich das Bein hoch oder dusche ich das Bein kalt ab				
4. nach dem Anlegen der Kompression bewege ich mich mindestens 20 Minuten oder massiere das Bein				
5. wenn die Kompression tagsüber zu fest wird, lege ich meine Beine hoch oder bewege mich				
6. ich trage eine Kompression (Verband, Strumpf) jeden Tag				
7. ich trage eine Kompression (Verband, Strumpf) nur tagsüber				

wenn Sie in den vergangenen 12 Monaten einen Kompressionsverband aus Binden getragen haben, gehen Sie bitte weiter zu Frage 8

wenn Sie in den vergangenen 12 Monaten einen Kompressionsstrumpf getragen haben, gehen Sie nun bitte weiter zu Frage 14

1.1 Maßnahmen zur Kompression	ja, stimmt genau (1)	eher ja (2)	eher nein (3)	nein, stimmt nicht (4)
1.1.b Kompressionsverband aus Binden				
8. ich lege den Kompressionsverband selber an				
9. ich wickle das Bein mit 2 Binden				
10. ich polstere die offenen Stellen unter den Binden ab				
11. ich wickle die Binden so, dass der Druck vom Fußgelenk zum Knie hin abnimmt				
12. wenn der Kompressionsverband sich lockert, wickle ich das Bein neu				
13. ich Sorge dafür, dass die Binden nicht verrutschen				

andere Maßnahmen, welche ich durchführe:.....
.....

1.1 Maßnahmen zur Kompression	ja, stimmt genau (1)	eher ja (2)	eher nein (3)	nein, stimmt nicht (4)
1.1.c Kompressionsstrümpfe				
14. ich ziehe mindestens jeden 2.Tag einen frischen Kompressionsstrumpf an				
15. wenn der Kompressionstrumpf ausleierte, ziehe ich ihn nicht mehr an				
16. ich lasse Sitz / Qualität der Kompressionsstrümpfe mind. alle 6 Monate von einem Arzt prüfen				
17. ich besorge alle 6 Monate neue Kompressionsstrümpfe				

andere Maßnahmen, welche ich durchführe:.....
.....

 Intensivpflege-Halle-GmbH	Pflege von Menschen mit chronischen Wunden	QM- Handbuch Kapitel ...
	Expertenstandard 03	Anlage 10

Zusatzinstrument „Wittener Aktivitätenkatalog“ BEI VENÖS BEDINGT OFFENEN BEINEN

Patient/ in	Geb.datum	Erhebungsdatum
-------------	-----------	----------------

1 Maßnahmen zur Verhinderung eines Blutstaus in den Beinen				
1.1 Maßnahmen zur Kompression	ja, stimmt genau (1)	eher ja (2)	eher nein (3)	nein, stimmt nicht (4)
1.1.a allgemein				
1. wenn ich ein geschlossenes Bein habe, ziehe ich einen Kompressionsstrumpf an				
2. ich lege den Kompressionsverband/ -strumpf morgens sofort beim Aufstehen an				
3. wenn das Bein vor dem Anlegen der Kompression geschwollen ist, lege ich das Bein hoch oder dusche ich das Bein kalt ab				
4. nach dem Anlegen der Kompression bewege ich mich mindestens 20 Minuten oder massiere das Bein				
5. wenn die Kompression tagsüber zu fest wird, lege ich meine Beine hoch oder bewege mich				
6. ich trage eine Kompression (Verband, Strumpf) jeden Tag				
7. ich trage eine Kompression (Verband, Strumpf) nur tagsüber				

wenn Sie in den vergangenen 12 Monaten einen Kompressionsverband aus Binden getragen haben, gehen Sie bitte weiter zu Frage 8

wenn Sie in den vergangenen 12 Monaten einen Kompressionsstrumpf getragen haben, gehen Sie nun bitte weiter zu Frage 14

1.1 Maßnahmen zur Kompression	ja, stimmt genau (1)	eher ja (2)	eher nein (3)	nein, stimmt nicht (4)
1.1.b Kompressionsverband aus Binden				
8. ich lege den Kompressionsverband selber an				
9. ich wickle das Bein mit 2 Binden				
10. ich polstere die offenen Stellen unter den Binden ab				
11. ich wickle die Binden so, dass der Druck vom Fußgelenk zum Knie hin abnimmt				
12. wenn der Kompressionsverband sich lockert, wickle ich das Bein neu				
13. ich Sorge dafür, dass die Binden nicht verrutschen				

andere Maßnahmen, welche ich durchführe:.....
.....

1.1 Maßnahmen zur Kompression	ja, stimmt genau (1)	eher ja (2)	eher nein (3)	nein, stimmt nicht (4)
1.1.c Kompressionsstrümpfe				
14. ich ziehe mindestens jeden 2.Tag einen frischen Kompressionsstrumpf an				
15. wenn der Kompressionstrumpf ausleierte, ziehe ich ihn nicht mehr an				
16. ich lasse Sitz / Qualität der Kompressionsstrümpfe mind. alle 6 Monate von einem Arzt prüfen				
17. ich besorge alle 6 Monate neue Kompressionsstrümpfe				

andere Maßnahmen, welche ich durchführe:.....
.....

 Intensivpflege-Halle-GmbH	Pflege von Menschen mit chronischen Wunden	QM- Handbuch Kapitel ...
	Expertenstandard 03	Anlage 9

**Zusatzinstrument „Wound-QoL“
LEBENSQUALITÄTSBOGEN CHRONISCHE WUNDEN**

Patient/ in	Geb.	Erhebungsdatum
-------------	------	----------------

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,
neben der medizinischen Behandlung Ihrer chronischen Wunde möchten wir gern erfahren, wie sehr Ihre Erkrankung Sie in Ihrer persönlichen Lebensführung einschränkt.
Für Ihre Mitarbeit bedanken wir uns im Voraus!

Mit den folgenden Fragen möchten wir erfahren, wie es Ihnen mit Ihrer/Ihren chronischen Wunde(n) geht.
Bitte setzen Sie pro Zeile genau ein Kreuz.

In den letzten 7 Tagen...	Gar nicht	Etwas	Mittelmäßig	Ziemlich	Sehr
1. ...hatte ich Schmerzen in der Wunde	0	1	2	3	4
2. ...hatte ich einen unangenehmen Geruch in der Wunde	0	1	2	3	4
3. ...hatte ich störenden Wundausfluss	0	1	2	3	4
4. ...war mein Schlaf durch die Wunde beeinträchtigt	0	1	2	3	4
5. ...war die Behandlung der Wunde für mich belastend	0	1	2	3	4
6. ...war ich wegen der Wunde niedergeschlagen	0	1	2	3	4
7. ...hat es mich frustriert, dass die Heilung so lange dauert	0	1	2	3	4
8. ...habe ich mir Sorgen wegen meiner Wunde gemacht	0	1	2	3	4
9. ...hatte ich Angst vor einer Verschlechterung oder vor neuen Wunden	0	1	2	3	4
10. ...hatte ich Angst, mich an der Wunde zu stoßen	0	1	2	3	4
11. ...konnte ich mich wegen der Wunde schlecht fortbewegen	0	1	2	3	4
12. ...war das Treppensteigen wegen der Wunde mühsam	0	1	2	3	4
13. ...hatte ich wegen der Wunde Probleme mit Alltagstätigkeiten	0	1	2	3	4
14. ...waren meine Freizeitaktivitäten wegen der Wunde eingeschränkt	0	1	2	3	4
15. ...musste ich wegen der Wunde Aktivitäten mit Anderen einschränken	0	1	2	3	4
16. ...fühlte ich mich wegen der Wunde abhängig von der Hilfe Anderer	0	1	2	3	4
17. ...war die Wunde für mich eine finanzielle Belastung	0	1	2	3	4
Wound-QoL-Gesamtwert	Σ				

„Wound-QoL“ Fragebogen zur Lebensqualität bei chronischen Wunden, Augustin et al. 2014, Blome et al. 2014

Auswertung:

- Punkte: 0-gar nicht, 1-etwas, 2-mittelmäßig, 3-ziemlich und 4-sehr
- mindestens 13 von 17 Fragen müssen beantwortet werden
- Summe geteilt durch Anzahl beantworteter Fragen = Wound-QoL-Gesamtwert
- Bereiche in denen der Patient mit ‚ziemlich‘ oder ‚sehr‘ geantwortet hat zeigen Handlungsbedarf auf

 Intensivpflege-Halle-GmbH	Pflege von Menschen mit chronischen Wunden	QM- Handbuch Kapitel ...
	Expertenstandard 03	Anlage 8

C) vorhandene wundbezogene Hilfsmittel	
Kompressionsstrümpfe	
Orthesen	
druckreduzierende Matratzen	
D) Selbstmanagementkompetenzen von Patienten und Angehörigen	
krankheitsspezifische Maßnahmen ☐ entstauende Maßnahmen ☐ Kompression (Anziehen, Pflegen, Umgang mit kompressionsbedingten Beschwerden) ☐ Aktivierung des Sprunggelenkes und der Muskelpumpe ☐ Hochlegen der Beine ☐ Fußpflege und -inspektion ☐ präventive Maßnahmen bei Diabetischem Fußulcus (z.B. Fußpflege, Umgang mit Schuhen) ☐ Druckentlastung der Wunde (Hilfsmittel, Bewegungsförderung / Umlagerung) ☐ Gefäßtraining; Gehtraining	
zum Umgang mit Einschränkungen	
zur Wunde und Verbandswechsel (Wundgeruch, Schmerzen)	
Erhalt von Alltagsaktivitäten (z.B. Einkaufen, Hobbies)	
Hautschutz / Hautpflege	
Ernährung	
Blutzuckereinstellung	
Rauchentwöhnung	
Protokoll- Version-Nr. 1 Seite 2 von 2 Stand	

 Intensivpflege-Halle-GmbH	Pflege von Menschen mit chronischen Wunden	QM- Handbuch Kapitel ...
	Expertenstandard 03	Anlage 8

wund- und therapiebedingte Einschränkungen	
Patient/ in	Geburtsdatum
Diagnose	☐ Ersteinschätzung Datum:..... ☐ Folgeeinschätzung Datum:.....

A) Patienten- / Angehörigenwissen	
zu Ursachen der Wunde	
zur Heilung der Wunde und Vorstellungen zur Wundheilungszeit	
zu Symptomen (z.B. Geruch, Exsudat, Juckreiz)	
zur Bedeutung spezieller Maßnahmen (z.B. Druckentlastung, Bewegung, Kompression)	
B) Wund- und therapiebedingte Einschränkung	
Schmerzen (Stärke, Qualität, Häufigkeit, Dauer, Situationen die mit Schmerzen einhergehen, Ort, Erfahrungen mit Maßnahmen zur Verbesserung der Schmerzen)	
Mobilitäts- und Aktivitätseinschränkungen	
Schlafstörungen	
Abhängigkeit von personeller Hilfe	
Jucken und Schwellen der Beine	
Schwierigkeiten bei Kleidungs- und Schuhwahl	
Schwierigkeiten zur Aufrechterhaltung der persönlichen Hygiene	
psychosoziale Aspekte (z.B. soziale Isolation, Machtlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Trauer, Depression, Energielosigkeit, Sorgen, Frustration, Mangel an Selbstwertgefühl, Hilflosigkeit, Gefühl des Kontrollverlustes)	

 Intensivpflege-Halle-GmbH	Pflege von Menschen mit chronischen Wunden	QM- Handbuch Kapitel ...
	Expertenstandard 03	Anlage 7

5. Wundgröße									
Länge (in cm)									
Breite (in cm)									
Tiefe (in cm)									
6. Unterminierung									
☐ ja >									
☐ nein									
7. Wundgrund/ Gewebeart									
☐ Granulationsgewebe									
☐ Fibringewebe									
☐ Epithelgewebe									
☐ Nekrose									
☐ Muskeln									
☐ Faszie									
☐ Sehnen									
☐ Knochen									
☐ Fettgewebe									
☐ Dermis									
☐ Sonstiges									
8. Exsudat/ Transsudat									
Häufigkeit des Verbandwechsels									
Anzahl der durchnässten Kompressen									
☐ kein: abgeheilt oder trockene Wunde									
☐ wenig: Wundbett feucht, Verband trocken									
☐ gering: Wundbett feucht, etwas aus dem Verband austretend									
☐ moderat: deutlich flüssig im Wundbett, über 50% d. Verbandes erschöpft									
☐ serös / blutig (serosanguinous): wässrig, hell rot bis rosa									
☐ serös: wässrig, klar, hell, gelblich									
☐ serös / eitrig: undurchsichtig									
☐ eitrig: undurchsichtig, gelblich bis grün mit faulem / schlechten Geruch									
☐ Sonstiges									
9. Wundgeruch									
☐ ja									
☐ nein									
10. Wundrand									
☐ intakt									
☐ nekrotisch									
☐ unterminiert									
☐ wulstig									
☐ mazeriert									
☐ rosig									
☐ Sonstiges									
Rückschluss auf Wundheilungsstörung									
☐ Bildung von Hyperkeratosen									
☐ Nekrosen und Einblutungen durch unzureichende Druckentlastung									
☐ Sonstiges									
11. Wundumgebung									
☐ intakt									
☐ gerötet									
☐ geschwollen									
☐ mazeriert									
☐ trocken									
☐ feucht									
☐ Wärmeentwicklung									
☐ die Farbe									
☐ Rückschluss auf Infektionen									
☐ Rückschluss auf mangelnde Druckentlastung									
☐ Rückschluss auf Hautirritationen durch Kompressionsstrümpfe									
☐ Sonstiges									

 Intensivpflege-Halle-GmbH	Pflege von Menschen mit chronischen Wunden	QM- Handbuch Kapitel ...
	Expertenstandard 03	Anlage 7

Wundassessment – sekundär heilende Wunden

Patient/ in	Geburtsdatum
-------------	--------------

1. Medizinische Wunddiagnose

Grunderkrankungen

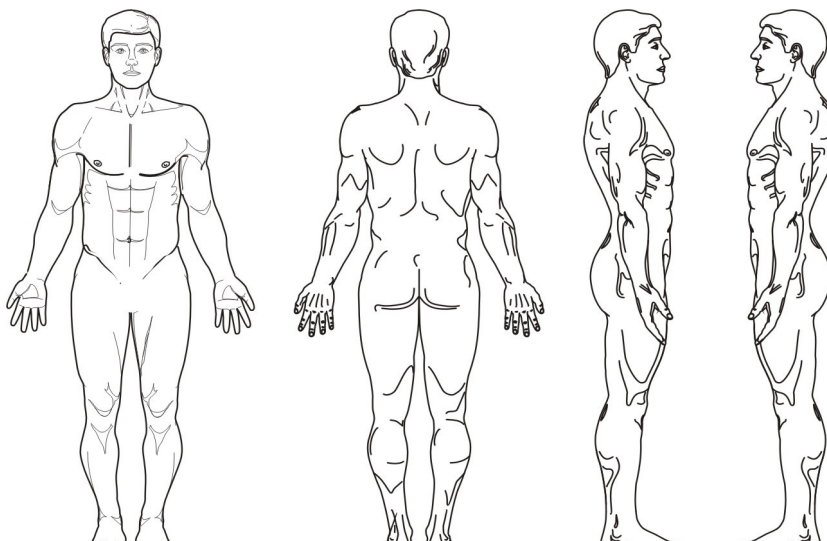
Art der Wunde / Wundentstehung

☐ Verbrennung
☐ Postoperative Wunde.....
☐ Tumor.....
☐ Hautdefekt.....
☐

bisherige diagnostische und therapeutische Maßnahmen

2. Wundlokalisation

graphische Dokumentation anhand eines Körperschemas



fachlich korrekte verbale Dokumentation

☐ cranial ☐ dorsal ☐ caudal ☐ plantar ☐ proximal ☐ distal ☐ anterior
☐ posterior ☐ superior ☐ inferior ☐ lateral ☐ medial ☐ ventral
☐

3. Wunddauer

Wunde besteht seit Entstehungsort:

4. Rezidivzahl

Zahl der Rezidive: Rezidivfreie Zeit:
Beschreibung

 Intensivpflege-Halle-GmbH	Pflege von Menschen mit chronischen Wunden	QM- Handbuch Kapitel ...
	Expertenstandard 03	Anlage 6

5. Wundgröße									
Länge (in cm)									
Breite (in cm)									
Tiefe (in cm)									
6. Unterminierung									
☐ ja >									
☐ nein									
7. Wundgrund/ Gewebeart									
☐ Granulationsgewebe									
☐ Fibringewebe									
☐ Epithelgewebe									
☐ Nekrose									
☐ Muskeln									
☐ Faszie									
☐ Sehnen									
☐ Knochen									
☐ Fettgewebe									
☐ Dermis									
☐ Sonstiges									
8. Exsudat/ Transsudat									
Häufigkeit des Verbandwechsels									
Anzahl der durchnässten Kompressen									
☐ kein: abgeheilt oder trockene Wunde									
☐ wenig: Wundbett feucht, Verband trocken									
☐ gering: Wundbett feucht, etwas aus dem Verband austretend									
☐ moderat: deutlich flüssig im Wundbett, über 50% d. Verbandes erschöpft									
☐ serös / blutig (serosanguinous): wässrig, hell rot bis rosa									
☐ serös: wässrig, klar, hell, gelblich									
☐ serös / eitrig: undurchsichtig									
☐ eitrig: undurchsichtig, gelblich bis grün mit faulem / schlechten Geruch									
☐ Sonstiges									
9. Wundgeruch									
☐ ja									
☐ nein									
10. Wundrand									
☐ intakt									
☐ nekrotisch									
☐ unterminiert									
☐ wulstig									
☐ mazeriert									
☐ rosig									
☐ Sonstiges									
Rückschluss auf Wundheilungsstörung									
☐ Bildung von Hyperkeratosen									
☐ Nekrosen und Einblutungen durch unzureichende Druckentlastung									
☐ Sonstiges									
11. Wundumgebung									
☐ intakt									
☐ gerötet									
☐ geschwollen									
☐ mazeriert									
☐ trocken									
☐ feucht									
☐ Wärmeentwicklung									
☐ die Farbe									
☐ Rückschluss auf Infektionen									
☐ Rückschluss auf mangelnde Druckentlastung									
☐ Rückschluss auf Hautirritationen durch Kompressionsstrümpfe									
☐ Sonstiges									

Wundassessment – Diabetischer Fußulcus

Patient/ in

Geburtsdatum

1. Medizinische Wunddiagnose

Grunderkrankungen

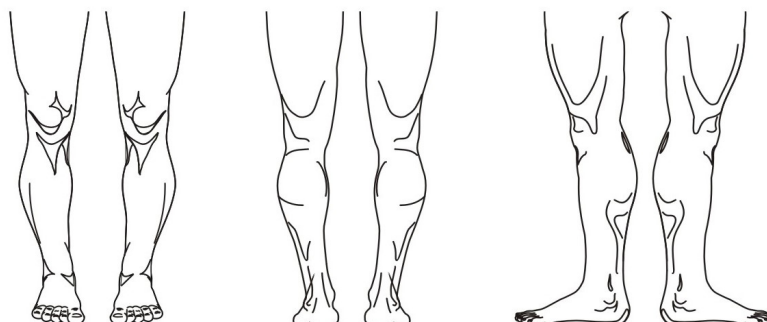
Schweregradeinteilung der Wunde bzw. der Grunderkrankung durch Wagner-Armstrong-Klassifikation

	0	1	2	3	4	5
A	☐ prä- oder post-ulcerative Läsion	☐ oberflächige Wunde	☐ Wunde bis zur Ebene von Sehne oder Kapsel	☐ Wunde bis zur Ebene von Knochen oder Gelenk	☐ Nekrose von Fußteilen	☐ Nekrose des gesamten Fußes
B	☐ mit Infektion	☐ mit Infektion	☐ mit Infektion	☐ mit Infektion	☐ mit Infektion	☐ mit Infektion
C	☐ mit Ischämie	☐ mit Ischämie	☐ mit Ischämie	☐ mit Ischämie	☐ mit Ischämie	☐ mit Ischämie
D	☐ mit Infektion und Ischämie	☐ mit Infektion und Ischämie	☐ mit Infektion und Ischämie	☐ mit Infektion und Ischämie	☐ mit Infektion und Ischämie	☐ mit Infektion und Ischämie

bisherige diagnostische und therapeutische Maßnahmen

2. Wundlokalisation

graphische Dokumentation anhand eines Körperschemas



fachlich korrekte verbale Dokumentation

☐ cranial ☐ dorsal ☐ caudal ☐ plantar ☐ proximal ☐ distal ☐ anterior
☐ posterior ☐ superior ☐ inferior ☐ lateral ☐ medial ☐ ventral

☐

3. Wunddauer

Wunde besteht seit

Entstehungsort:

4. Rezidivzahl

Zahl der Rezidive:

Rezidivfreie Zeit:

Beschreibung